Nutridit

GUÍA PRÁCTICA · EDICIÓN 2026

Compruébalo tú mismo

Lo que puedes verificar por tu cuenta antes de pagar por una consulta, por una prueba o por un producto. Con procedimientos oficiales y datos publicados.

Álvaro Ferrer Ossorio · Dietista-Nutricionista colegiado AND-01847
Nutrición clínica · Salud digestiva y menopausia · Sevilla y consulta online

ANTES DE EMPEZAR

Para qué sirve esta guía

Cada año se gasta mucho dinero en pruebas sin respaldo, en planes que nadie supervisa y en productos que prometen lo que no pueden cumplir. Casi todo eso se puede detectar antes de pagar, y para hacerlo no hace falta ser sanitario.

Esta guía reúne lo que cualquiera puede comprobar por su cuenta: cómo verificar la titulación de quien te atiende, qué procedimientos existen de verdad para diagnosticar una intolerancia, qué dice el etiquetado que la ley obliga a poner, y qué cifras de referencia usan los organismos oficiales.

Todo lo que aparece aquí procede de fuentes públicas: protocolos del Ministerio de Sanidad, documentos de posición de sociedades científicas, reglamentos europeos de etiquetado, valores de referencia de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y bases de datos oficiales de composición de alimentos. Las fuentes están citadas al final.

QUÉ ENCONTRARÁS

Bloque 1. Verificar a quien te atiende: titulaciones, registro oficial de colegiados, señales de alarma y qué debe incluir una consulta.

Bloque 2. Verificar lo que te venden: cómo se diagnostican de verdad las intolerancias y qué pruebas existen para estudiar el intestino.

Bloque 3. Verificar lo que compras: lectura de etiquetas, azúcares reales y cómo se calcula el Nutri-Score.

Bloque 4. Datos para tener a mano: proteína por alimento y pérdidas por cocinado.

Bloque 5. Para llevar a tus citas: preguntas para tu médico, diario de comidas y glosario.

UN LÍMITE IMPORTANTE

Este documento es informativo y general. No contiene indicaciones para ninguna persona concreta, no sustituye una consulta y no sirve para autodiagnosticarse. El diagnóstico corresponde siempre a un médico.

01

Verificar a quien te atiende

Tres titulaciones distintas se presentan con nombres parecidos y solo una está regulada como profesión sanitaria. Comprobarlo lleva dos minutos.

1.1 Qué titulación tiene cada figura
1.2 Cómo verificar la colegiación
1.3 Ocho señales de alarma
1.4 Qué debe incluir una consulta y qué debes recibir

1.1

Qué titulación tiene cada figura

Los tres términos circulan como sinónimos y describen situaciones muy distintas. La diferencia importa porque solo una de las tres es profesión sanitaria regulada.

PROFESIÓN SANITARIA

Dietista-Nutricionista

Grado universitario en Nutrición Humana y Dietética, o la diplomatura anterior. Es profesión sanitaria titulada y regulada por la Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias. Puede colegiarse y su colegiación es verificable en un registro público. Realiza valoración e intervención nutricional.

PROFESIÓN SANITARIA

Médico especialista en Endocrinología y Nutrición

Licenciatura o grado en Medicina más formación especializada vía MIR. Diagnostica enfermedades, prescribe fármacos y solicita pruebas. Es quien pone el diagnóstico sobre el que después trabaja el resto del equipo.

Nutricionista, coach nutricional, asesor o experto en nutrición

Ninguno de estos términos corresponde a una titulación oficial ni está protegido por ley. Puede usarlos alguien con un grado universitario y también alguien con un curso de fin de semana. Por sí solos no informan de la formación de quien los emplea.

LA COMPROBACIÓN QUE RESUELVE LA DUDA

En lugar de fijarte en cómo se presenta alguien, pregunta directamente: **«¿cuál es tu número de colegiado y en qué colegio estás?»**. Un dietista-nutricionista colegiado responde en un segundo, porque lo tiene que llevar en su documentación. Quien no puede responder no está colegiado, y eso no lo convierte en mal profesional, pero sí te dice qué tienes delante.

1.2

Cómo verificar la colegiación

La colegiación es obligatoria para ejercer una profesión sanitaria y los registros son públicos. Comprobarla es gratuito y no requiere identificarse.

El procedimiento, paso a paso

#	Qué hacer
1	Pide el **número de colegiado** y el **colegio al que pertenece**. Suelen aparecer en la web, en la factura y en la placa de la consulta.
2	Localiza la web del colegio profesional de dietistas-nutricionistas de esa comunidad autónoma, o la del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas si el colegio no es evidente.
3	Busca la sección de **ventanilla única**, que todos los colegios están obligados a tener por la Ley 17/2009 sobre libre acceso a las actividades de servicio.
4	Dentro está el **registro de colegiados**. Introduce el número o el nombre y comprueba que el estado figura como **ejerciente**.
5	Si el resultado no aparece, escribe al colegio. Están obligados a atender consultas sobre la colegiación de sus miembros.

> **QUÉ TE DICE Y QUÉ NO TE DICE**
>
> Que alguien esté colegiado confirma que tiene la titulación oficial, que está habilitado para ejercer y que responde ante un código deontológico y ante un colegio si algo va mal. No garantiza que sea el profesional adecuado para tu caso, y esa parte la valoras tú en la primera consulta.

Otras dos comprobaciones que puedes hacer

- **Registro sanitario del centro.** Toda consulta debe estar inscrita en el registro de centros sanitarios de su comunidad autónoma y mostrar su número de autorización de forma visible.
- **Factura.** Los servicios de nutrición prestados por un dietista-nutricionista están exentos de IVA por el artículo 20.1.3.º de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido. En la factura debe constar esa exención.

1.3

Ocho señales de alarma

Ninguna de estas ocho es concluyente por separado. Dos o más juntas conviene mirarlas con calma antes de pagar nada.

1. **Promete una cifra y un plazo**
   «Diez kilos en tres meses.» La respuesta a un cambio en la alimentación varía mucho entre personas. Prometer una cifra concreta antes de valorar un caso es publicidad, no criterio.

2. **Vende suplementos propios o cobra comisión**
   Cuando quien recomienda un producto gana con su venta, la recomendación deja de ser independiente. Pregunta directamente si obtiene alguna comisión.

3. **Ofrece test de intolerancias sin respaldo**
   Test de IgG o IgG4 frente a alimentos, biorresonancia, kinesiología o análisis de cabello. El bloque 2 explica qué dicen las sociedades científicas sobre ellos.

4. **Entrega la misma pauta a todo el mundo**
   Un plan idéntico repartido a personas distintas indica que no hubo valoración individual. Si el documento que recibes no menciona nada de lo que contaste, sospecha.

5. **Interpreta analíticas sin ser médico**
   Un dietista-nutricionista trabaja con tu analítica como contexto. Diagnosticar a partir de ella corresponde a un médico.

6. **No hay seguimiento previsto**
   Una pauta sin revisión posterior es un documento, no un acompañamiento. Pregunta cuántas visitas están previstas y cada cuánto.

7. **Cobra sin factura o solo admite efectivo**
   La factura es un derecho y además es lo que te permite pedir reembolso a un seguro que lo contemple.

8. **Usa fotos de antes y después o testimonios de pacientes**
   La comunicación sanitaria tiene límites sobre el uso de casos de pacientes y sobre atribuir eficacia sin respaldo. Un profesional que los respeta transmite que conoce su marco normativo.

1.4

Qué debe incluir una consulta

No hay una tarifa oficial ni un contenido obligatorio, y por eso conviene saber qué se considera práctica habitual antes de comparar precios.

Lo que suele contener una primera visita

Elemento	Qué significa
Entrevista	Hábitos, horarios, historia dietética, actividad, contexto familiar y laboral. Es la parte que más tiempo ocupa.
Revisión de informes	Analíticas o informes que aportes, usados como contexto y sin sustituir el criterio de tu médico.
Objetivos acordados	Fijados contigo y por escrito, en términos de hábitos y de proceso.
Pauta escrita	Documento personalizado con estructura, cantidades orientativas y alternativas.
Plan de seguimiento	Cuántas visitas se prevén y con qué separación.
Factura	Con los datos del profesional y la exención de IVA indicada.

Preguntas útiles antes de reservar

- ¿Cuánto dura la primera consulta y cuánto las revisiones?
- ¿Recibo algo por escrito y en cuánto tiempo?
- ¿Cuántas visitas suele necesitar un caso como el mío?
- ¿Hay permanencia o número mínimo de sesiones?
- ¿Vendes suplementos o productos?
- ¿Trabajas coordinado con mi médico si hace falta?
- ¿Qué pasa si necesito cancelar o cambiar una cita?

SOBRE EL PRECIO

Un precio bajo puede significar una consulta más corta o sin material escrito, y un precio alto no garantiza nada por sí solo. Compara **tiempo de consulta, qué te llevas por escrito y qué seguimiento incluye**, que son los tres elementos que de verdad diferencian un servicio de otro.

02

Verificar lo que te venden

Las intolerancias y los problemas digestivos tienen procedimientos de diagnóstico definidos en guías clínicas. Conocerlos permite distinguirlos de lo que se comercializa sin respaldo.

2.1 Cómo se diagnostica de verdad una intolerancia
2.2 Qué dicen las sociedades científicas sobre los test que se venden
2.3 Las pruebas que existen para estudiar el intestino

2.1

Cómo se diagnostica una intolerancia

Cada situación tiene su procedimiento, y en todos los casos lo indica y lo interpreta un médico.

Intolerancia a la lactosa y a la fructosa

Prueba: test de hidrógeno espirado. Se mide el hidrógeno del aire que exhalas antes y después de tomar una cantidad conocida del azúcar que se estudia. Si no se absorbe bien, las bacterias del intestino lo fermentan y producen hidrógeno, que pasa a la sangre y se elimina por el aliento.

Fase	En qué consiste
Preparación	Sin antibióticos las semanas previas, sin probióticos ni fermentados los días anteriores, y una cena sencilla y baja en fibra el día antes. Cada centro indica sus plazos exactos.
Muestra basal	Se sopla en ayunas para tener el valor de partida.
Sustrato	Se toma la lactosa, la fructosa o el sustrato que corresponda, disuelto en agua.
Mediciones	Se sopla a intervalos regulares durante **dos o tres horas**.
Resultado	Se valora el aumento de hidrógeno respecto al valor basal, junto con los síntomas registrados durante la prueba.

Enfermedad celíaca

El protocolo del Ministerio de Sanidad establece una secuencia concreta: primero **serología**, con los anticuerpos antitransglutaminasa tisular de tipo IgA como marcador principal, y después **biopsia duodenal** cuando los valores no superan ampliamente el límite de normalidad. La biopsia se toma por endoscopia, con varias muestras de bulbo y de duodeno.

> **EL ERROR MÁS FRECUENTE Y MÁS CARO**
>
> **Quitar el gluten antes de que te estudien invalida el diagnóstico.** Tanto los anticuerpos como las lesiones intestinales solo aparecen mientras se consume gluten. Quien deja de tomarlo por su cuenta y después acude al médico puede tener que volver a introducirlo durante semanas para poder estudiarse. Si sospechas celiaquía, consulta antes de cambiar nada.

Alergia alimentaria

Es un mecanismo distinto de una intolerancia y la estudia un alergólogo, con pruebas cutáneas, determinación de IgE específica y, cuando procede, prueba de provocación controlada en medio hospitalario.

2.2

Los test que se venden por internet

Se comercializan como diagnóstico de intolerancias alimentarias y no forman parte de ningún protocolo clínico. El más extendido tiene además un documento de posición específico en su contra.

SIN RESPALDO

Test de IgG o IgG4 frente a alimentos

La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica publicó un informe de su grupo de trabajo cuyo título es explícito: la determinación de IgG4 frente a alimentos **no se recomienda como herramienta diagnóstica**. El motivo es que la presencia de estos anticuerpos indica que el organismo ha estado expuesto repetidamente a ese alimento y lo ha reconocido, y se interpreta como un signo de **tolerancia inmunológica normal**. La Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología respaldó ese documento, y la sociedad canadiense mantiene una posición equivalente.

QUÉ SIGNIFICA EN LA PRÁCTICA

Un resultado positivo en uno de estos test suele señalar los alimentos que más comes, porque son aquellos a los que más te has expuesto. Retirarlos de la dieta a partir de ese resultado empobrece la alimentación sin motivo y dificulta identificar el problema real.

Otros métodos comercializados

Método	Qué propone	Situación
Biorresonancia	Detectar intolerancias midiendo frecuencias electromagnéticas	Sin base fisiológica reconocida
Kinesiología aplicada	Deducir intolerancias por la fuerza muscular al sostener un alimento	Sin base fisiológica reconocida
Análisis de cabello	Determinar intolerancias o déficits a partir de una muestra de pelo	No validado para este uso
Test de citotoxicidad	Observar la reacción de células sanguíneas ante extractos de alimentos	Sin validación diagnóstica

TRES PREGUNTAS ANTES DE PAGAR UNA PRUEBA

1. ¿Qué sociedad científica la recomienda y en qué documento?
2. ¿La indica y la interpreta un médico?
3. ¿Qué haría diferente contigo el profesional según el resultado?

Si la tercera pregunta no tiene una respuesta clara, la prueba no va a cambiar nada de lo que hagas.

2.3

Pruebas para estudiar el intestino

Estas son las que aparecen en las guías clínicas. Todas las indica un médico y cada una responde a una pregunta distinta.

NO INVASIVA

Calprotectina fecal

Mide una proteína procedente de los glóbulos blancos que se libera en el intestino cuando hay inflamación. Su utilidad principal es **distinguir un trastorno funcional, como el síndrome de intestino irritable, de una enfermedad inflamatoria intestinal**, y así evitar pruebas innecesarias. Los valores orientativos habituales sitúan por debajo de 50 µg/g el rango normal y por encima de 100 a 150 µg/g el resultado sugestivo de inflamación, con una zona intermedia que suele repetirse. Los puntos de corte varían entre laboratorios.

NO INVASIVA

Test de hidrógeno espirado

Con lactosa o fructosa estudia la absorción de ese azúcar. Con lactulosa o glucosa se emplea en el estudio del sobrecrecimiento bacteriano, valorando el aumento de gases en la primera parte de la prueba. Existen equipos que miden también metano.

NO INVASIVA

Coprocultivo y estudio de parásitos

Busca bacterias o parásitos concretos en heces. Es la prueba indicada cuando se sospecha una causa infecciosa, especialmente tras un viaje o un cuadro agudo.

ENDOSCÓPICA

Endoscopia digestiva alta con biopsia

Permite ver el esófago, el estómago y el duodeno, y tomar muestras. Es el procedimiento que confirma la enfermedad celíaca cuando la serología lo indica.

ENDOSCÓPICA

Colonoscopia

Explora el colon y permite tomar biopsias. Se indica ante señales de alarma, en el estudio de enfermedad inflamatoria intestinal y en los programas de cribado por edad.

SOBRE LOS ESTUDIOS DE MICROBIOTA

Los análisis que describen la composición de la microbiota intestinal son una herramienta útil en investigación. En la consulta cotidiana su interpretación clínica todavía está en discusión, y un resultado por sí solo no establece un diagnóstico ni indica un tratamiento.

03

Verificar lo que compras

El etiquetado está regulado y obliga al fabricante a darte una información concreta. Saber leerla cambia bastante la compra.

3.1 Cómo leer una etiqueta
3.2 Azúcares en productos cotidianos
3.3 Nutri-Score por dentro

3.1

Cómo leer una etiqueta

El Reglamento europeo 1169/2011 fija qué información es obligatoria y cómo debe presentarse. Con cuatro comprobaciones se obtiene casi todo.

1 · El orden de los ingredientes

La lista va **de mayor a menor cantidad**. El primer ingrediente es el más abundante. Si el azúcar aparece entre los tres primeros, el producto lleva bastante azúcar independientemente de lo que diga el frente del envase.

2 · Los azúcares con otros nombres

Aparecen bajo muchas denominaciones y todas cuentan: jarabe de glucosa, jarabe de glucosa y fructosa, dextrosa, maltodextrina, azúcar invertido, melaza, concentrado de zumo de frutas, miel, jarabe de maíz y jarabe de agave. Repartirlo entre varias hace que cada una caiga más abajo en la lista.

3 · La tabla nutricional

Es obligatoria y se expresa **por 100 gramos o 100 mililitros**, lo que permite comparar productos entre sí. Si hay columna por ración, comprueba qué considera el fabricante una ración: suele ser menor de lo que se consume.

4 · Las declaraciones permitidas

El Reglamento 1924/2006 define cada expresión con un umbral concreto, así que estas frases significan algo preciso.

Declaración	Qué exige
Sin azúcares	Menos de 0,5 g de azúcares por 100 g o 100 ml.
Sin azúcares añadidos	No se ha añadido ningún azúcar. El producto puede contener los azúcares propios del alimento.
Bajo contenido de azúcares	Como máximo 5 g por 100 g en sólidos, o 2,5 g por 100 ml en líquidos.
Bajo en grasa	Como máximo 3 g de grasa por 100 g, o 1,5 g por 100 ml.
Fuente de fibra	Al menos 3 g de fibra por 100 g.
Alto contenido de fibra	Al menos 6 g de fibra por 100 g.
Fuente de proteínas	Al menos el 12 % de la energía del producto procede de proteínas.
Bajo contenido de sal	Como máximo 0,3 g de sal por 100 g o 100 ml.

UNA REGLA QUE AHORRA TIEMPO

Lee siempre la **parte de atrás** antes que la de delante. El frente del envase es diseño y comunicación; la lista de ingredientes y la tabla nutricional son obligatorias y están normalizadas.

3.2

Azúcares en productos cotidianos

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los azúcares libres se mantengan por debajo del 10 % de la energía diaria, y sugiere como objetivo adicional bajar del 5 %. En una dieta de 2.000 kilocalorías ese 5 % equivale a **unos 25 gramos al día**, alrededor de seis cucharaditas.

QUÉ SON LOS AZÚCARES LIBRES

Los que añade el fabricante, el cocinero o el consumidor, más los presentes de forma natural en la **miel, los jarabes, los zumos de fruta y los concentrados de zumo**. El azúcar de una pieza de fruta entera o el de la leche quedan fuera de esa cuenta.

Equivalencia en cucharaditas

Una cucharadita rasa de azúcar son unos 4 gramos. Los valores siguientes son órdenes de magnitud habituales por categoría, tomados del etiquetado; cada marca declara los suyos y conviene comprobarlos en el envase.

Producto	Ración	Azúcares	Cucharaditas
Refresco de cola	330 ml	≈ 35 g	≈ 9
Bebida energética	250 ml	≈ 27 g	≈ 7
Té helado envasado	330 ml	≈ 23 g	≈ 6
Zumo de fruta envasado	200 ml	≈ 20 g	≈ 5
Cacao soluble	15 g	≈ 11 g	≈ 3
Yogur de sabores	125 g	≈ 13 g	≈ 3
Cereales de desayuno azucarados	30 g	≈ 8 g	≈ 2
Barrita de cereales	25 g	≈ 7 g	≈ 2
Galletas tipo María	4 uds	≈ 7 g	≈ 2
Kétchup	15 g	≈ 4 g	≈ 1

EL CÁLCULO QUE PUEDES HACER EN EL SUPERMERCADO

Mira los gramos de azúcares del envase completo y **divide entre cuatro**. Ese número son las cucharaditas de azúcar que contiene. Con las bebidas el resultado suele sorprender, porque se toman de una vez.

3.3

Nutri-Score por dentro

Es un sistema voluntario de etiquetado frontal que resume la composición nutricional en una letra de la A a la E. Conocer su cálculo explica los resultados que a mucha gente le chocan.

Cómo se calcula

El algoritmo asigna dos grupos de puntos por cada 100 gramos o mililitros de producto y resta el segundo del primero.

Puntos que penalizan	Puntos que compensan
Valor energético	Fruta, verdura y legumbre
Azúcares	Fibra
Grasas saturadas	Proteínas
Sal	

La puntuación final se traduce en una letra y en un color. La revisión del algoritmo publicada en 2023 ajustó las escalas, endureció el tratamiento de la sal y del azúcar, introdujo una penalización para los edulcorantes en bebidas y limitó el efecto compensador de la proteína en las carnes rojas. Existen escalas específicas para bebidas, para grasas y aceites, para frutos secos y para quesos.

Qué queda fuera del cálculo

- **El grado de procesamiento.** El algoritmo valora composición, sin tener en cuenta cómo se ha elaborado el producto.
- **Los aditivos.** No intervienen en la puntuación.
- **La cantidad que se consume.** Todo se calcula por 100 gramos, así que un producto que se toma en porciones pequeñas y otro que se toma en grandes cantidades se puntúan igual.
- **El contexto de la dieta.** Compara productos, sin valorar el conjunto de lo que se come.

> **CÓMO USARLO BIEN**
>
> El Nutri-Score funciona para **comparar productos de la misma categoría**: dos cereales de desayuno, dos pizzas, dos yogures. Comparar categorías distintas entre sí lleva a conclusiones extrañas, porque un aceite de oliva y un refresco se puntúan con escalas pensadas para cosas diferentes.

04

Datos para tener a mano

Valores de composición de alimentos y de referencia poblacional, para consultar cuando hagan falta.

4.1 Proteína por alimento y por ración
4.2 Qué se pierde al cocinar

4.1

Proteína por alimento

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria establece una ingesta de referencia para población adulta de **0,83 g de proteína por kilo de peso y día**, con un requerimiento medio de 0,66 g/kg. Es un valor poblacional de referencia, no una indicación individual.

La tercera columna indica cuánto habría que tomar de cada alimento, tal como se come, para reunir 20 gramos de proteína.

Carnes, pescados y huevo

Alimento	g proteína /100 g	Para 20 g
Atún en conserva al natural	25	**80 g**
Sardina en conserva	23	**87 g**
Pechuga de pollo	23	**87 g**
Lomo de cerdo	21	**95 g**
Ternera magra	21	**95 g**
Salmón	20	**100 g**
Gamba	19	**105 g**
Merluza	17	**118 g**
Huevo	12,5	**160 g · 3 uds**

Lácteos

Alimento	g proteína /100 g	Para 20 g
Queso curado	32	**63 g**
Queso fresco	12	**167 g**
Requesón	11	**182 g**
Yogur natural	3,8	**526 g**
Leche	3,1	**645 ml**

Valores redondeados de composición de alimentos. Varían con el corte, la pieza y la preparación.

4.1 · SEGUNDA PARTE

Proteína de origen vegetal

Las mismas columnas para legumbres, frutos secos y cereales. En las legumbres conviene mirar si el valor corresponde al alimento seco o ya cocido, porque entre uno y otro hay casi el triple de diferencia.

Legumbres y derivados de la soja

Alimento	g proteína /100 g	Para 20 g
Soja texturizada, en seco	50	**40 g**
Seitán	24	**83 g**
Lenteja cocida	9	**222 g**
Garbanzo cocido	8,5	**235 g**
Tofu	8	**250 g**
Alubia cocida	7	**286 g**
Guisante	5,5	**364 g**

Frutos secos, cereales y otros

Alimento	g proteína /100 g	Para 20 g
Cacahuete	26	**77 g**
Almendra	21	**95 g**
Avena en copos	13	**154 g**
Pan blanco	8	**250 g**
Quinoa cocida	4,4	**455 g**
Pasta cocida	4	**500 g**
Arroz cocido	2,6	**769 g**

CÓMO LEER ESTAS TABLAS

La columna central sirve para comparar alimentos entre sí. La de la derecha sirve para hacerse una idea de las cantidades en el plato, que es donde aparecen las sorpresas: un alimento con mucha proteína por cada 100 gramos puede aportar poco si la ración habitual es pequeña, y al revés.

4.2

Qué se pierde al cocinar

Cocinar modifica el contenido de algunos nutrientes. Las diferencias relevantes son menos de las que se suelen atribuir, y se concentran en un grupo concreto.

Qué se ve afectado y qué no

Nutriente	Comportamiento con el calor y el agua
Vitamina C	El más sensible de todos. Se degrada con el calor y se disuelve en el agua de cocción.
Vitaminas del grupo B	Solubles en agua. Parte pasa al caldo, especialmente en cocciones largas y con mucha agua.
Folatos	Sensibles al calor y solubles en agua.
Vitaminas A, D, E y K	Liposolubles. Bastante estables frente al agua; se ven más afectadas por temperaturas muy altas y por el medio graso.
Minerales	No se destruyen con el calor. Pueden pasar al agua de cocción, que los conserva.
Proteína	Se desnaturaliza, lo cual modifica su textura sin reducir su valor nutricional. En muchos casos mejora su digestibilidad.
Fibra	Estable. Cambia de textura y se mantiene.

El factor que más influye

Más que el método en sí, lo que determina la pérdida es **cuánta agua se usa, cuánto tiempo y cuánta superficie del alimento está en contacto con ella**. De ahí que hervir en abundante agua y desechar el caldo sea lo que más pérdidas produce, mientras que el vapor, el microondas y las cocciones cortas conserven más.

CUATRO DECISIONES PRÁCTICAS

1. Aprovecha el agua de cocción en sopas, cremas o guisos.
2. Corta en piezas grandes lo que vayas a hervir.
3. Cocina el tiempo justo y con el recipiente tapado.
4. Alterna crudo y cocinado a lo largo de la semana.

UNA IDEA QUE CONVIENE MATIZAR

Cocinar reduce algunos nutrientes y aumenta la disponibilidad de otros. El licopeno del tomate y algunos carotenoides se absorben mejor tras el calor, y la cocción reduce compuestos que dificultan la absorción de minerales en legumbres y cereales. Comparar crudo con cocinado en términos absolutos simplifica demasiado.

05

Para llevar a tus citas

Tres herramientas para imprimir o copiar. Cuanta mejor información lleves a una consulta, más rendimiento le sacas al tiempo que dura.

5.1 Diez preguntas para tu médico
5.2 Diario de comidas y síntomas
5.3 Glosario

5.1

Diez preguntas para tu médico

Una consulta dura poco y se olvida la mitad de lo que se quería preguntar. Llévalas escritas y anota la respuesta en el momento.

01

¿Cuál es el diagnóstico, con su nombre completo?

02

¿Con qué prueba se ha confirmado y cuándo se hizo?

03

¿Queda algo por descartar antes de dar el diagnóstico por cerrado?

04

¿Debo cambiar algo de mi alimentación antes de las pruebas pendientes?

05

¿Puedo tener una copia por escrito del informe y de los resultados?

06

¿Qué señales indicarían que debo volver antes de la próxima cita?

07

¿El tratamiento que me indica afecta a la absorción de algún nutriente?

08

¿Ve adecuado que trabaje la parte nutricional con un dietista-nutricionista?

09

¿Hay algo que le gustaría que ese profesional tuviera en cuenta?

10

¿Cuándo debo volver a revisión y con qué pruebas?

UN APUNTE

Pedir el informe por escrito es un derecho reconocido en la Ley 41/2002 de autonomía del paciente. Tenerlo evita repetir pruebas y facilita cualquier segunda opinión.

5.2

Diario de comidas y síntomas

Catorce días de registro dan mucha más información que cualquier recuerdo. Anota lo que comes tal como lo comes, sin cambiar nada por el hecho de estar registrándolo.

CÓMO RELLENARLO

Escribe alimentos y bebidas sin pesar nada. En la columna de síntomas anota lo que notes y a qué hora. En descanso, apunta las horas de sueño y si te has despertado. Rellénalo en el momento y evita reconstruirlo por la noche.

Día	Desayuno	Media mañana	Comida	Merienda	Cena	Síntomas y hora	Descanso
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

Este registro es tuyo y contiene información sobre tu salud. Compártelo solo con el profesional que te atienda.

5.3

Glosario

Términos que aparecen en informes y en consulta, explicados en una línea.

Alergia alimentaria. Reacción del sistema inmunitario frente a un alimento, mediada habitualmente por anticuerpos IgE. Puede ser grave.

Intolerancia alimentaria. Dificultad para digerir o absorber un componente de un alimento, sin participación del sistema inmunitario.

Antitransglutaminasa (anti-TG2). Anticuerpo que se determina en sangre como primer paso del estudio de la enfermedad celíaca.

Serología. Análisis de anticuerpos en sangre.

Biopsia duodenal. Muestra de tejido del duodeno tomada por endoscopia para examinarla al microscopio.

Calprotectina fecal. Proteína medible en heces que se eleva cuando existe inflamación intestinal.

SIBO. Siglas en inglés de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado.

Test de hidrógeno espirado. Prueba que mide gases en el aire exhalado tras tomar un azúcar concreto.

FODMAP. Siglas que agrupan varios tipos de hidratos de carbono fermentables presentes en muchos alimentos.

Dieta baja en FODMAP. Estrategia de restricción temporal y supervisada, seguida de una fase de reintroducción ordenada.

Microbiota intestinal. Conjunto de microorganismos que habitan el intestino.

Disbiosis. Término general para describir una alteración en la composición de la microbiota. Su uso clínico está en discusión.

Síndrome de intestino irritable. Trastorno digestivo funcional que se diagnostica por criterios clínicos tras descartar otras causas.

Trastorno funcional. Alteración del funcionamiento sin lesión estructural detectable en las pruebas.

Enfermedad inflamatoria intestinal. Grupo de enfermedades con inflamación crónica del tubo digestivo, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.

Azúcares libres. Los añadidos a un alimento más los presentes en miel, jarabes, zumos y concentrados de zumo.

Azúcares totales. Todos los azúcares del producto, incluidos los propios del alimento.

Ingesta de referencia. Valor establecido para la población general, sin equivaler a la necesidad de una persona concreta.

Composición corporal. Proporción de los distintos componentes del cuerpo, entre ellos masa muscular, grasa y agua.

Bioimpedancia. Método de estimación de la composición corporal mediante el paso de una corriente eléctrica de baja intensidad.

Densidad nutricional. Cantidad de nutrientes de interés que aporta un alimento en relación con su energía.

Perfil lipídico. Conjunto de parámetros de grasas en sangre, como colesterol y triglicéridos.

Resistencia a la insulina. Situación en la que las células responden menos a la insulina de lo esperado.

Adherencia. Grado en que una pauta se sigue de forma sostenida en el tiempo.

REFERENCIAS

Fuentes

Todos los datos, umbrales y procedimientos de esta guía proceden de las fuentes siguientes.

Procedimientos y posiciones científicas

- Stapel SO y cols. *Testing for IgG4 against foods is not recommended as a diagnostic tool: EAACI Task Force Report*. Allergy, 2008. Documento de posición de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica.
- Bock SA. *AAAAI support of the EAACI Position Paper on IgG4*. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2010.
- Sociedad Canadiense de Alergia e Inmunología Clínica. *Position statement on the testing of food-specific IgG*.
- Ministerio de Sanidad. *Protocolo para el diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca*.
- Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. *Test del hidrógeno espirado: metodología e indicaciones*.
- Literatura de gastroenterología sobre calprotectina fecal como marcador diferencial entre patología orgánica y funcional, publicada en *Gastroenterología y Hepatología* y en la *Revista Española de Enfermedades Digestivas*.

Valores de referencia y etiquetado

- Organización Mundial de la Salud. *Directriz: ingesta de azúcares para adultos y niños*, 2015.
- Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. *Scientific Opinion on Dietary Reference Values for protein*. EFSA Journal, 2012;10(2):2557.
- Reglamento (UE) 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.
- Reglamento (CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables.
- Algoritmo del Nutri-Score y su revisión de 2023, junto con la información publicada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
- Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA) para los valores de composición.

Marco normativo citado

- Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias.
- Ley 41/2002 de autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
- Ley 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicio, que obliga a los colegios profesionales a mantener una ventanilla única.
- Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, artículo 20.1.3.º

SOBRE LAS CIFRAS

Los valores de composición de alimentos están redondeados y varían según la pieza, el corte y la preparación. Los contenidos de azúcares de productos comerciales son órdenes de magnitud habituales por categoría y cada fabricante declara los suyos en el envase. Los puntos de corte de laboratorio varían entre centros.

Nutridit

Consulta de nutrición clínica

Salud digestiva y acompañamiento nutricional de la menopausia.
Consulta presencial en Sevilla y por videollamada para toda España.

Álvaro Ferrer Ossorio · Dietista-Nutricionista colegiado AND-01847

Máster en Nutrición Clínica y Dietoterapia · 12 años de ejercicio

Consulta · Calle Rioja 12, 2.ª planta · 41001 Sevilla

Teléfono · 954 55 12 40 · **Email** · hola@nutridit.es

Web · www.nutridit.es · **Instagram** · @nutridit

Centro sanitario inscrito con NICA 45.912

Documento informativo de carácter general. No constituye consejo sanitario individualizado, no sustituye la consulta con un profesional y no debe utilizarse para autodiagnóstico ni para modificar un tratamiento. El diagnóstico corresponde siempre a un médico. Edición 2026.